PTSD - stres pourazowy i skutki przemocy

Zaburzenia związane ze stresem

- Zespół stresu pourazowego - PTSD.
- Złożony zespół stresu pourazowego - CPTSD.
- Zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą - PGD.
- Zaburzenia przystosowania.
- Reaktywne zaburzenie przywiązania.

Stres pourazowy wiąże się z jawnymi i ukrytymi skutkami przemocy oraz innych doświadczeń traumatycznych. Nie każda osoba po traumie rozwija PTSD.

DSM i ICD

DSM i ICD to odrębne systemy klasyfikacji klinicznej. Nie należy utożsamiać DSM wyłącznie z psychologią, a ICD wyłącznie z psychiatrią.

PTSD wprowadzono do **DSM-III w 1980 r.** Rozwój diagnozy wiązał się m.in. z badaniami weteranów wojny w Wietnamie oraz osób po innych traumach. W DSM-5 PTSD należy do zaburzeń związanych z traumą i stresorami. National Center for PTSD - historia diagnozy.

Obraz kliniczny PTSD

1. **Intruzje:** natrętne, niechciane wspomnienia, myśli, wyobrażenia i sny; flashbacki mogą mieć charakter przeżywania zdarzenia tak, jakby działo się ponownie.
2. **Unikanie:** omijanie myśli, uczuć, miejsc i sytuacji przypominających traumę.
3. **Negatywne przekonania i nastrój:** obwinianie, utrwalone negatywne emocje, wycofanie i ograniczenie zainteresowań.
4. **Pobudzenie i reaktywność:** nadmierna czujność, drażliwość, nasilony odruch przestrachu, trudności ze snem i koncentracją.

Kryteria PTSD w DSM-5

A-H: schemat do nauki

Dla osób **powyżej 6. roku życia** wymagane są wszystkie grupy warunków A-H. Kryteria PTSD pozostały takie same w DSM-5-TR. National Center for PTSD - DSM-5 i DSM-5-TR.

Kryterium	Warunek
A - ekspozycja	rzeczywista lub zagrażająca śmierć, poważne obrażenia albo przemoc seksualna; kwalifikowana droga ekspozycji
B - intruzje	co najmniej **1 z 5** objawów
C - unikanie	co najmniej **1 z 2** objawów
D - poznanie i nastrój	co najmniej **2 z 7** objawów, nowych lub nasilonych po zdarzeniu

Kryterium	Warunek
E - pobudzenie i reaktywność	co najmniej **2 z 6** objawów, nowych lub nasilonych po zdarzeniu
F - czas	objawy B-E trwają **dłużej niż miesiąc**
G - znaczenie kliniczne	istotne cierpienie lub pogorszenie funkcjonowania
H - wykluczenie	objawów nie wyjaśnia działanie substancji lub inne schorzenie

A - drogi ekspozycji

- Bezpośrednie doświadczenie zdarzenia.
- Bezpośrednie obserwowanie zdarzenia dotyczącego innych osób.
- Wiadomość o zdarzeniu dotyczącym bliskiej osoby; przy śmierci chodzi o śmierć gwałtowną lub wypadkową.
- Powtarzalny lub skrajny kontakt z drastycznymi szczegółami zdarzeń.

Samo oglądanie tragicznych wydarzeń w mediach zwykle nie spełnia kryterium A. W ostatnim wariancie ekspozycja medialna może kwalifikować się, jeśli jest związana z pracą zawodową. Veterans Affairs Canada - kryterium A.

B-E - grupy objawów

- **B:** natrętne wspomnienia; związane ze zdarzeniem sny; flashbacki; silne cierpienie przy przypomnieniu; reakcje fizjologiczne na przypomnienie.
- **C:** unikanie wewnętrznych wspomnień, myśli lub uczuć; unikanie zewnętrznych przypomnień.
- **D:** amnezja ważnych aspektów; utrwalone negatywne przekonania; zniekształcone obwinianie; utrwalone negatywne emocje; utrata zainteresowań; poczucie oddzielenia od innych; ograniczenie pozytywnych emocji.
- **E:** drażliwość lub agresywne wybuchy; ryzykowne/autodestrukcyjne zachowanie; nadmierna czujność; nasilony odruch przestrachu; problemy z koncentracją; zaburzenia snu.

Veterans Affairs Canada - kryteria B-E.

Specyfikatory i zmiany kryteriów

- **Z objawami dysocjacyjnymi:** depersonalizacja lub derealizacja.
- **Z opóźnionym ujawnieniem:** pełne kryteria spełnione dopiero co najmniej sześć miesięcy po zdarzeniu.
- Usunięto dawny wymóg silnego strachu, bezradności lub przerażenia podczas traumy. Brak takiej reakcji nie wyklucza PTSD. National Center for PTSD - specyfikatory i zmiany.

PTSD a CPTSD

W ICD-11 PTSD obejmuje:

1. Ponowne przeżywanie w teraźniejszości.
2. Unikanie.
3. Poczucie aktualnego zagrożenia.

CPTSD obejmuje dodatkowo trudności w organizacji siebie:

- Zaburzenia regulacji emocji.
- Utrwalony negatywny obraz siebie i niskie poczucie własnej wartości.
- Trudności w utrzymywaniu relacji i bliskości emocjonalnej.

DSM-5 nie wyróżnia CPTSD jako osobnej diagnozy. Powtarzalna, długotrwała trauma zwiększa prawdopodobieństwo CPTSD, ale nie jest koniecznym warunkiem rozpoznania. National Center for PTSD - CPTSD.



Zestawienie grup objawów. DSM-5 nie wyróżnia CPTSD jako osobnego rozpoznania.

Schemat. PTSD i dodatkowe trudności w organizacji siebie w CPTSD; źródło: National Center for PTSD, wskazane powyżej.

PTSD, ostra reakcja i żałoba

Pojęcie	Najważniejsze rozróżnienie
PTSD w DSM	określona ekspozycja, grupy objawów, czas i wpływ na funkcjonowanie
Ostre zaburzenie stresowe - ASD	objawy w okresie od 3 dni do miesiąca po traumie; nie jest obowiązkowym etapem PTSD
Żałoba	reakcja na stratę; sam smutek nie oznacza PTSD
Przedłużona żałoba - PGD	odrębne rozpoznanie uwzględniające objawy, czas i kontekst kulturowy

VA - ASD, APA - PGD.

Trauma i żałoba · Śmierć, strata i żałoba.

Czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Przed zdarzeniem

- Wcześniejsze traumy, zwłaszcza w dzieciństwie.
- Wcześniejsze zaburzenia psychiczne, w tym epizody depresyjne.
- Historia zaburzeń psychicznych w rodzinie.
- Separacja, zaniedbania i deficyty opieki w dzieciństwie.
- Uwarunkowania biologiczne i genetyczne.

Podczas zdarzenia i po nim

- Ciężkość i czas trwania zdarzenia.
- Bliskość fizyczna oraz zaangażowanie emocjonalne.
- Dysocjacja i silne reakcje podczas traumy.
- Dalsze stresory i trwanie zagrożenia.
- Małe wsparcie lub niewspierające środowisko społeczne.

Czynniki ochronne: wsparcie społeczne, umiejętności radzenia sobie i zasoby poznawcze. PTSD może współwystępować z depresją i zaburzeniami lękowymi. Czynniki ryzyka nie są kryteriami diagnozy. NIMH - PTSD, ryzyko i odporność.

Mechanizmy biologiczne

Badania dotyczą m.in. objętości i aktywności hipokampa, reaktywności ciała migdałowatego, warunkowania lęku oraz regulacji układów neuroprzekaźnikowych. Związek biologicznej cechy z PTSD nie oznacza, że jest ona samodzielnym testem diagnostycznym.

Rozpowszechnienie PTSD

Rozpowszechnienie życiowe oznacza wystąpienie zaburzenia kiedykolwiek w życiu. Roczne i bieżące odnoszą się do innych okresów. Odsetek w całej populacji ma inny mianownik niż odsetek wśród osób narażonych na traumę.

Koenen i współautorzy przeanalizowali 26 badań populacyjnych WMH obejmujących **71 083 dorosłych**. Przy kryteriach DSM-IV rozpowszechnienie życiowe wyniosło:

Populacja	Odsetek
Cała próba	**3,9%**
Osoby z ekspozycją na traumę	**5,6%**

Koenen i in., 2017 - *Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys*, DOI: 10.1017/S0033291717000708.

Nie można przenosić wyników próby klinicznej albo określonego rodzaju traumy na wszystkie osoby po każdym zdarzeniu traumatycznym. Porównania wymagają zgodności populacji, okresu i kryteriów.

Badania

Publikacja	Pytanie i wniosek	Ograniczenie
Koenen i in., 2017	częstość PTSD w różnych populacjach; 3,9% całej próby i 5,6% osób narażonych	kryteria DSM-IV; różnice między krajami i metodami
Gilbertson i in., 2002	badanie bliźniąt jednojajowych różniących się ekspozycją bojową wskazało na mniejszą objętość hipokampa jako możliwy czynnik podatności	nie jest to samodzielny test diagnostyczny ani dowód nieuchronności PTSD

Gilbertson i in., 2002 - *Smaller hippocampal volume predicts pathologic vulnerability to psychological trauma*, *Nature Neuroscience* 5:1242-1247, DOI: 10.1038/nn958.

Powiązania

- Wiktymizacja - doświadczenie przemocy i jego konsekwencje.
- Przemoc w izolacji - warunki instytucjonalne i skutki dla osoby pokrzywdzonej.
- Dowodzenie - rozpoznanie PTSD samo nie ustala sprawcy ani przebiegu czynu.

Źródła: dostęp 12.10.2026.